Médecin traitant : la Cour des comptes veut imposer un minimum de patients à chaque généraliste

La rédaction du Cercle des Généralistes · 13 octobre 2026 · 15 min de lecture

SITUATION

La Cour des comptes veut obliger chaque généraliste libéral installé à suivre un minimum de patients comme médecin traitant, 500 selon sa piste.

Son rapport « Le dispositif du médecin traitant. Une ambition partagée à mieux soutenir », demandé par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, a été rendu public le 30 septembre 2026. Le 6 octobre 2026, le député Guillaume Garot a déposé une proposition de loi qui retient, elle, une part d'au moins 30 % de la patientèle. Rien de tout cela ne s'applique aujourd'hui : il faudrait une négociation conventionnelle ou une loi.

CONTEXTE

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a saisi la Cour le 8 juillet 2025, pour un bilan du dispositif 20 ans après sa création et des pistes « en vue de renforcer l'accès aux soins des patients ». La Cour précise que son rapport n'évalue pas ses résultats en matière de santé publique ni de maîtrise médicalisée de la dépense.

Pourquoi la Cour en arrive à un seuil : son constat de départ est démographique. Selon elle, « à court terme, la démographie médicale entraîne une érosion du vivier de médecins traitants ». 50 % seulement des 100 000 médecins généralistes en exercice en 2024 ont une activité de médecin traitant. D'après la CNAM, le nombre de généralistes libéraux médecins traitants a baissé d'environ 4 % entre 2016 et 2023. Les nouvelles installations ne compensent pas les départs. La génération qui assure le plus souvent cette mission approche de la retraite, et la suivante l'exerce moins souvent. Le nombre moyen de jours travaillés par un généraliste est passé de 239 en 2016 à 216 en 2023. Les généralistes partent aussi vers d'autres exercices : salariat, exercice mixte, remplacement, centres de soins non programmés, passés de quelques dizaines en 2018 à près de 600.

Du côté des patients, au 30 juin 2025, 48,7 millions d'assurés, soit 88,5 % de la population adulte, avaient déclaré un médecin traitant ; 6,3 millions n'en avaient pas. Selon la Drees, citée par la Cour, 2 généralistes sur 3 déclaraient en 2022 refuser de nouveaux patients comme médecin traitant, contre 53 % en 2019. En 2023, 1 patient sans médecin traitant sur 3 l'était après la cessation d'activité de son ancien médecin. Pour la Cour, l'absence de médecin traitant relèverait pourtant, pour la plus grande part, d'une « situation choisie » : seuls 40 % des 6,3 millions d'assurés sans médecin traitant se voient appliquer les pénalités de remboursement. 1 assuré sans médecin traitant sur 4 reçoit de sa caisse un « médecin traitant fictif » pour éviter un renoncement aux soins, ce que la Cour lit comme « la reconnaissance des difficultés d'accès au médecin traitant ».

À long terme, la Cour juge la tendance plus favorable, avec l'arrivée des étudiants formés depuis la fin du numerus clausus : selon les projections de la Drees qu'elle cite, la densité de généralistes progresserait de 15 % entre 2025 et 2040.

Un seuil de patientèle existe déjà dans la convention : selon la Cour, l'aide à l'embauche d'un assistant médical exige une patientèle au moins égale au 30e percentile de la distribution nationale. Le rapport rappelle aussi qu'un généraliste suit en moyenne 2 200 patients au Royaume-Uni, et que l'Italie plafonne la patientèle à 1 500.

Le rapport a été largement repris. Egora a titré le 30 septembre « Médecin traitant : un rapport de la Cour des comptes recommande d'imposer un minimum de 500 patients par généraliste ». Le même jour, Le Quotidien du Médecin titrait « Médecins traitants : 8 553 généralistes libéraux dans le viseur de la Cour des comptes ». Que Choisir a écrit le 3 octobre que le rapport « préconise de fixer un seuil minimal de 500 patients suivis par médecin ». Parmi les articles que nous avons pu lire, celui de Vidal, tiré d'une dépêche de l'APM, est le seul à préciser que ce seuil « pourrait être » de 500 patients, et qu'il serait modulé.

La proposition de loi n° 3264, « assurant l'accès à un médecin traitant pour chaque patient », a été renvoyée à la commission des affaires sociales.

CE QUI EST CONFIRMÉ

Sur les 53 840 médecins généralistes libéraux recensés en 2024, 8 553 n'exercent pas de missions de médecin traitant ou le font pour une faible patientèle, sous le seuil de 200 patients médecin traitant vus dans l'année. La Cour ne compte que les patients de 16 ans et plus. Sur le champ de son étude, 53 183 médecins, elle compte 44 630 médecins traitants, 6 892 médecins à faible patientèle et 1 661 médecins qu'aucun patient n'a déclarés comme médecin traitant. S'y ajoutent 5 533 médecins généralistes des centres de santé, soit un peu plus de 50 000 médecins traitants.

Selon le tableau 14 du rapport, les 8 553 médecins peu ou pas médecins traitants exercent pour 75 % dans les grands centres urbains, contre 50 % des médecins traitants, et pour 65 % dans les communes où l'accessibilité aux généralistes est la plus élevée. 17 % exercent en zone d'intervention prioritaire, contre 25 % des médecins traitants, et 40 % hors des zones d'intervention prioritaire et d'action complémentaire, contre 30 %. 21 % ont un mode d'exercice particulier, notamment la médecine d'urgence, SOS Médecins, l'acupuncture ou l'homéopathie ; 12 % ont 70 ans ou plus, et 18 % ont commencé leur activité libérale en 2023 ou en 2024. 86 % sont en secteur 1, contre 97 % des médecins traitants ; 6 % sont en secteur 2 hors Optam et 3 % en secteur 3.

Recommandation n° 2 de la Cour : « Rendre obligatoire, dans le cadre des prochaines négociations conventionnelles, un seuil minimal de patientèle prise en charge en tant que médecin traitant, pour tout médecin généraliste libéral installé (CNAM) ». Le seuil de 500 patients, retenu par la CNAM comme seuil d'une activité significative de médecin traitant, « pourrait être envisagé ». Il conduirait à 300 à 500 patients médecin traitant de plus pour les médecins concernés, soit un potentiel de 2,5 à 4 millions de patients. Selon la Cour, un seuil uniforme pourrait avoir des effets contre-productifs dans certaines situations ; elle propose de le moduler selon le mode d'exercice, la quotité de travail, l'ancienneté d'installation, la structure de patientèle (âgée, en ALD, précaire) ou les missions universitaires ou territoriales.

96 % des patients en ALD ont déclaré un médecin traitant, contre 83 % des 5,4 millions de bénéficiaires de la C2S, des assurés précaires dont la couverture s'est fortement dégradée depuis

2019. La Cour recense encore 575 000 patients en ALD sans médecin traitant, et environ 850 000 bénéficiaires de la C2S dans la même situation. En 2023, plus de 20 % des patients qui avaient un généraliste libéral pour médecin traitant ne l'avaient pas vu dans l'année. Rapporté à la population, cela représenterait près de 11 millions d'assurés, selon la Cour.

Depuis le 1er janvier 2026, le forfait médecin traitant remplace le forfait patientèle et la rémunération sur objectifs de santé publique. Selon l'Assurance Maladie, son socle annuel par patient est de 5 € de 7 à 74 ans sans ALD, de 15 € avant 7 ans et de 75 à 79 ans, de 55 € à partir de 80 ans ou en ALD avant 80 ans, et de 100 € en ALD à partir de 80 ans, avec 10 € de plus pour un bénéficiaire de la C2S. Un patient qui n'a fait l'objet d'aucun acte facturé par le médecin ou son collaborateur dans les 2 années précédant la date du constat ne rapporte que 5 €. Le forfait est réservé aux médecins de secteur 1 et aux médecins de secteur 2 adhérents de l'Optam ou de l'Optam-ACO.

Selon la Cour, le forfait patientèle médecin traitant et la rémunération sur objectifs de santé publique ont représenté plus de 1,2 Md€ en 2024. Pour un généraliste libéral sans mode d'exercice particulier, ils représentaient en moyenne 23 400 € par an : 18 000 € de forfait et 5 400 € de rémunération sur objectifs. Le paiement à l'acte compte pour près de 80 % de la rémunération des généralistes libéraux. Selon la Cour, environ 15 % des généralistes libéraux médecins traitants emploient un assistant médical ; leur patientèle médecin traitant augmente de 19,5 % au bout de 4 ans, et l'aide à l'emploi a représenté 99 M€ en 2025 pour les généralistes libéraux. Les médecins exerçant en maison de santé pluriprofessionnelle refusent en moyenne moins de nouveaux patients comme médecin traitant. Les 7 autres recommandations portent sur les systèmes d'information, la couverture des publics vulnérables, les aides aux CPTS, l'enseignement du 2e cycle des études médicales, les outils numériques du médecin traitant, la part forfaitaire de la rémunération et les financements collectifs des MSP et des centres de santé.

La proposition de loi confie à la convention médicale la fixation d'une « fraction minimale de patients » qui ont désigné le médecin comme médecin traitant. Cette fraction ne peut être inférieure à 30 % de la patientèle ; elle est adaptée notamment à la quotité de travail, à l'ancienneté d'installation, aux caractéristiques de la patientèle et aux conditions d'exercice sur le territoire. Si aucune mesure n'est prise dans les 12 mois suivant la promulgation, le ministre chargé de la Santé la fixe après avis de la Haute Autorité de santé et du Conseil national de l'Ordre des médecins. Son article 2 interdit, dans le cadre d'une consultation ou d'une téléconsultation, toute prestation complémentaire payante visant à faciliter l'accès à une consultation, à un acte ou à un examen, en contrepartie d'un rendez-vous obtenu plus vite ou d'un accès facilité à un professionnel de santé.

CE QUI POSE QUESTION

Au 13 octobre 2026, 5 questions restent ouvertes. Le seuil se compterait-il en patients déclarés ou en patients vus ? Le rapport ne le dit pas, alors qu'il classe lui-même les médecins sur les patients vus dans l'année, et que près de 11 millions d'assurés n'ont pas vu leur médecin traitant dans l'année.

Les enfants compteraient-ils ? La Cour ne retient que les patients de 16 ans et plus, alors que le forfait médecin traitant couvre aussi les enfants.

Combien de généralistes suivent entre 200 et 500 patients médecin traitant ? Un seuil de 500 les placerait aussi en dessous, mais le rapport ne compte que ceux qui en suivent moins de 200, et son potentiel de 2,5 à 4 millions de patients ne porte que sur ces 8 553 médecins.

Que risquerait un médecin sous le seuil ? Ni le rapport ni la proposition de loi ne prévoient de conséquence : la proposition de loi renvoie les modalités à la convention.

Quand, et par quel chemin ? La Cour renvoie aux « prochaines négociations conventionnelles », sans date, alors que la convention en vigueur a été signée le 4 juin 2024. Le site de l'Assemblée nationale n'affiche ni rapporteur ni date d'examen pour la proposition de loi, et le rapport ne publie ni la réponse de la CNAM ni celle du ministère de la Santé.

L'IMPACT FINANCIER & ORGANISATIONNEL

La Cour chiffre l'effort à 300 à 500 patients médecin traitant de plus pour chaque médecin concerné. Calcul du Cercle sur la grille de l'Assurance Maladie : 300 patients de 7 à 74 ans sans ALD rapportent 1 500 € de forfait socle par an ; 300 patients en ALD de moins de 80 ans, 16 500 €. Les majorations de prévention, à 5 € par indicateur validé, et les consultations s'y ajoutent. Pour un médecin de secteur 2 hors Optam ou de secteur 3, le forfait est nul.

Chez un médecin traitant, chaque patient en ALD de moins de 80 ans sans acte facturé depuis 2 ans fait perdre 50 € de forfait par an (5 € au lieu de 55 €), et 95 € à partir de 80 ans (5 € au lieu de 100 €).

L'effort, lui, porte sur le suivi. Selon la Cour, un médecin traitant libéral suivait en moyenne 1 130 patients à ce titre en 2024, contre 919 en 2016, et les patients en ALD, de plus de 65 ans ou bénéficiaires de la C2S représentent en moyenne 56 % de son activité. Toujours selon la Cour, toutes choses égales par ailleurs, le poids du forfait médecin traitant ne passerait que de 11,8 % de la rémunération en 2024 à 13 % en 2028.

LE REGARD DU CERCLE

Un quota de patients est une mauvaise réponse, et ce sont les médecins qui la paieraient. D'abord parce qu'il fait porter aux généralistes installés une pénurie qu'ils n'ont pas créée : pendant des décennies, le numerus clausus a limité le nombre de médecins formés, jusqu'à la loi du 24 juillet 2019, et la Cour n'attend ses effets qu'à long terme. Un seuil ne crée pas de temps médical : il répartit l'effort entre ceux qui sont déjà là, ce que la Cour appelle elle-même « une meilleure répartition de l'effort de prise en charge ».

Ensuite parce qu'il frapperait d'abord les plus jeunes et ceux qui font autre chose d'utile. 33 % des 8 553 médecins visés ont 39 ans ou moins, et 18 % ont commencé leur activité libérale en 2023 ou en 2024. La Cour écrit pourtant que l'amélioration attendue suppose que « ne se dégrade pas davantage l'attractivité du dispositif vis-à-vis des jeunes médecins » : une contrainte de plus à l'installation pousserait vers le salariat ou le remplacement, les exercices qui vident déjà le vivier. Et 1 sur 4 de ces médecins voit déjà plus de 2 944 patients dans l'année, sans les suivre comme médecin traitant : leur imposer 500 patients suivis au long cours, c'est retirer du temps aux consultations ponctuelles qu'ils assurent.

Enfin parce qu'il change la règle du jeu, et qu'il paierait mal. La convention incitait ; le seuil imposerait, et la proposition de loi prévoit qu'à défaut d'accord dans les 12 mois, le ministre le fixe lui-même, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Ordre. À 5 € par an pour un patient de 7 à 74 ans sans ALD, le forfait ne paie pas le suivi qu'on demanderait, et il ne paie rien aux médecins de secteur 2 hors Optam ou de secteur 3.

Ce que la presse a manqué, c'est la cible. Elle a retenu un chiffre, 500, et une idée, l'obligation, alors que le rapport présente le seuil comme une piste à moduler. Ses propres tableaux montrent des médecins qu'on imagine mal : 3 sur 4 exercent dans les grands centres urbains, 40 % hors des zones d'intervention prioritaire et d'action complémentaire, contre 30 % des médecins traitants. Cité par Egora le 30 septembre, Bernard Lejeune, président de la 6e chambre de la Cour, les a décrits comme exerçant « majoritairement en secteur 2 ». Le tableau 14 de son rapport en compte 86 % en secteur 1.

Les leviers qui augmentent vraiment la capacité de suivi sont dans le rapport lui-même : l'assistant médical, l'exercice en maison de santé, et un forfait qui paie le suivi plutôt que la déclaration. L'Assurance Maladie le fait déjà en partie : un patient non vu depuis 2 ans ne rapporte que 5 €. Un seuil compté en patients déclarés irait à rebours, et fabriquerait des médecins traitants de papier, quand près de 11 millions d'assurés ne voient déjà pas le leur.

RECOMMANDATIONS

- **Généraliste libéral qui suit peu de patients comme médecin traitant** : Compter avec son logiciel ses patients médecin traitant de 16 ans et plus vus dans l'année, et faire confirmer le chiffre par sa CPAM : sous 200, il relève de la catégorie des 8 553 médecins recensés en 2024 ; entre 200 et 500, il serait sous le seuil envisagé, sans figurer parmi les médecins que chiffre la Cour. Puis transmettre à son syndicat les critères de modulation qui le concernent : mode d'exercice, temps partiel, installation récente, patientèle, missions universitaires ou territoriales.

- **Médecin traitant qui a des patients déclarés perdus de vue** : Repérer les patients qui l'ont déclaré et pour lesquels ni lui ni son collaborateur n'a facturé d'acte depuis 2 ans, en commençant par ceux en ALD, puis leur proposer une consultation de suivi : sans acte sur 2 ans, leur forfait tombe à 5 € par an, au lieu de 55 € ou de 100 €.
- **Médecin traitant qui refuse de nouveaux patients faute de temps** : Demander à sa CPAM les conditions de l'aide à l'emploi d'un assistant médical, avec lequel, selon la Cour, la patientèle médecin traitant augmente de 19,5 % au bout de 4 ans, et étudier l'exercice en maison de santé pluriprofessionnelle, où les médecins refusent moins de nouveaux patients.

Sources

Cour des comptes, Le dispositif du médecin traitant. Une ambition partagée à mieux soutenir (septembre 2026)

Assemblée nationale, proposition de loi n° 3264 assurant l'accès à un médecin traitant pour chaque patient

Assemblée nationale, dossier législatif de la proposition de loi n° 3264

Assurance Maladie, le nouveau forfait médecin traitant (page du 16 juin 2026)

Egora, « Médecin traitant : un rapport de la Cour des comptes recommande d'imposer un minimum de 500 patients par généraliste » (30 septembre 2026)

Le Quotidien du Médecin, « Médecins traitants : 8 553 généralistes libéraux dans le viseur de la Cour des comptes » (30 septembre 2026)

Vidal, d'après une dépêche de l'APM, « Médecin traitant : la Cour des comptes préconise une patientèle minimale obligatoire pour les généralistes » (1er octobre 2026)

Que Choisir, « 6,3 millions de patients sans médecin traitant » (3 octobre 2026)

Traçabilité : Cour des comptes ; Assemblée nationale ; Assurance Maladie (ameli.fr). Les articles de presse, lus le 13 octobre 2026, sont cités pour la façon dont ils ont rendu compte du rapport, jamais comme source d'un fait.